

# Le Empatie — Una Parola, Mille Sfumature

Salute Mentale · Sessione 03 · 4 marzo 2026

Questa lezione affronta uno dei concetti più abusati del nostro tempo: l'empatia. Non per celebrarla, ma per scomporla, metterla alla prova e capirne davvero la complessità — perché nel lavoro di cura usarla male può fare più danno che bene.

---

## Il problema con la parola "empatia"

Partiamo da una provocazione sana: la parola **empatia** è diventata uno slogan. Chiunque la usa, pochi sanno cosa significa davvero. Il prof Lorenzo Pezzoli la chiama "una maschera interiore" — e non lo dice per essere antipatico, lo dice perché è vero.

La versione popolare recita: *"mettersi nei panni degli altri."* Sembra bella. Ma se ci pensi, se tu ti metti nei panni di qualcuno, gli stai letteralmente togliendo i panni. Lo lasci nudo. **Ricoeur** — il filosofo citato nel materiale — lo dice chiaramente: prendersi il posto dell'altro significa lasciarlo senza il suo posto. E la sofferenza è una dimensione **identitaria**: appartiene a chi la vive, non a chi la osserva.

Il punto non è "capire tutto" dell'altro, ma **stare di fianco** a lui. Non al suo posto — di fianco. Così lui rimane titolare della sua esperienza e tu, da quella posizione diversa, puoi iniziare ad avvicinarti a una prospettiva che non è la tua.

"Il medico non muore con il paziente, ma può restargli accanto — accanto, e non al suo posto." — Ricoeur, citato da Pezzoli

---

# L'origine del concetto

Il termine **empatia** entra in italiano nel 1909, come traduzione dell'**Einfühlung** tedesco — "sentire dentro". Le radici vengono dalla filosofia e, in psicologia, il primo grande contributo arriva da **Theodor Lipps (1905)** con un'immagine che è rimasta famosa: l'acrobata e lo spettatore.

Lo spettatore guarda l'acrobata eseguire un volteggio pericoloso. Dentro di sé, qualcosa si attiva: rivive la propria paura, riproduce interiormente il movimento dell'altro. Non sta sul trapezio, ma qualcosa di quel volteggio risuona in lui. Lipps chiama questo processo imitazione interiore e già allora intuisce che si tratta di un fenomeno multidimensionale — non unitario, non semplice.

Un punto fermo per Lipps: "per comprendere la mente di altri uomini è necessario essere un uomo." Per empatizzare con la tristezza di qualcuno, devi aver vissuto la tristezza. La **base umana comune** è il presupposto.

Cent'anni dopo, **Vittorio Gallese (2003)** chiuderà il cerchio introducendo la teoria dei **neuroni specchio** e la **simulazione incarnata** (*embodied simulation*): il meccanismo neurologico che sottende imitazione, empatia e mentalismo. Quando vedo qualcuno compiere un'azione, nel mio cervello si attivano gli stessi neuroni che si attiverrebbero se fossi io a compierla. È automatico, pre-riflessivo, inconscio. Il corpo "mima" l'altro prima ancora che la mente lo decida.

---

## Empatia come concetto multidimensionale: Norma Feshbach (1987)

Come il benessere non è un concetto semplice ma si compone di dimensioni diverse, così l'empatia. La svolta decisiva la porta **Norma Feshbach**, psicologa americana che negli anni '80 scompone il costrutto identificando le sue componenti fondamentali.

Per la Feshbach l'empatia è una **esperienza affettiva condivisa** con tre dimensioni:

**Componente cognitiva 1 — Assunzione di prospettiva:** La capacità di decentrarsi, di "uscire da sé" per cogliere il punto di vista dell'altro. Questo richiede il superamento dell'egocentrismo piagetiano (stadio preoperatorio, dai 2 ai 6-7 anni). Prima dei 6 anni non può esistere vera empatia in questo senso — il cervello non ha ancora gli strumenti.

**Componente cognitiva 2 — Decodifica degli stati emotivi altrui:** La capacità di leggere i segnali emotivi dell'interlocutore, interpretarne lo stato interiore. Ogni emozione è un atto di valutazione protocognitiva della realtà — capire quello che l'altro sente richiede un'elaborazione cognitiva attiva.

**Componente affettiva — Risonanza emotiva:** La capacità di *sentire* qualcosa di simile a quello che prova l'altro. Per la Feshbach questa è **il sale dell'empatia** — senza di essa, non c'è vera empatia. Ma non è sufficiente da sola.

Pensala come le radici di un albero: la radice emotiva alimenta tutto. Ma senza il fusto cognitivo che porta linfa verso l'alto, la radice non produce frutti. Ti servono entrambe.

Un punto cruciale: per la Feshbach l'empatia funziona **solo se c'è distinzione tra sé e l'altro**. Genitori che si identificano completamente col figlio non riescono più a distinguere i propri sentimenti da quelli del figlio — e paradossalmente perdono la capacità empatica vera.

La **Teoria della Mente (TOM — Theory of Mind)**, che si sviluppa attorno ai 4 anni, è una tappa chiave: il bambino inizia a capire che gli altri possono sapere cose che lui non sa, avere credenze diverse, provare emozioni diverse, o nascondere emozioni. Wellman (2018) identifica cinque dimensioni:

| Tipo                         | Descrizione                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Diverse Desires (DD)</b>  | Le persone possono desiderare cose diverse                      |
| <b>Diverse Beliefs (DB)</b>  | Le persone possono credere cose diverse sulla stessa situazione |
| <b>Knowledge-Access (KA)</b> | Qualcosa può essere vero, ma qualcuno potrebbe non saperlo      |

| Tipo                       | Descrizione                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>False Belief (FB)</b>   | Qualcuno può credere falsamente qualcosa di diverso dal reale |
| <b>Hidden Emotion (HE)</b> | Qualcuno può sentirsi in un modo ma mostrarne uno diverso     |

## Le empatie al plurale: Martin Hoffman (2000)

Qui la lezione fa un salto qualitativo importante. **Martin Hoffman** non si accontenta del modello della Feshbach: per lui l'empatia non è solo complessa, è anche **evolutiva**. Non si nasce già con la stessa empatia che si ha a 30 anni — si trasforma e si raffina nel tempo, insieme allo sviluppo cognitivo.

Hoffman aggiunge anche una **dimensione motivazionale**: empatizzare con chi soffre attiva comportamenti prosociali. La sofferenza dell'altro mi fa stare male — e per ridurla aiuto l'altro. È una delle radici più arcaiche della moralità.

Fin qui ci siamo? Bene, ora viene la parte più interessante — le empatie una per una.

### I cinque stadi dell'empatia secondo Hoffman

#### Stadio 1 — Distress empatico globale (*dalla nascita al primo anno*)

Il neonato non distingue ancora sé dagli altri. Quando sente la sofferenza altrui, la "fa propria" — come se venisse da lui. È il **contagio emotivo**: involontario, automatico, senza alcuna mediazione cognitiva. Si vede nei neonati che piangono sentendo piangere un altro neonato.

Il contagio emotivo ha due meccanismi base: - **Imitazione motoria**: i muscoli del viso mimano l'espressione dell'altro, e questo provoca l'emozione corrispondente. Ekman (1992) lo dimostrò: imitare un'espressione facciale tende a produrre l'emozione associata. Darwin lo aveva già intuito nel 1872. - **Reazione circolare primaria**: risposta innata e selettiva al segnale sociale — i neonati reagiscono al pianto di altri neonati, non a rumori equivalenti di altra natura.

Nell'adulto il distress empatico globale si ritrova nell'innamoramento, nelle folle, in certi ambienti carichi di tensione emotiva.

### **Stadio 2 — Distress empatico egocentrico** (*dai 12 mesi circa*)

Il bambino inizia a distinguere sé dall'altro come entità fisiche separate. Sente la sofferenza dell'altro e tenta di aiutare — ma i suoi tentativi si basano su ciò che *lui* considera confortante. Un bambino che vede un amico piangere va dalla propria madre, non da quella dell'amico. Porta il proprio orsacchiotto, non quello dell'amico.

La risposta è genuina e motivata, ma ancora filtrata attraverso il proprio schema egocentrico.

### **Stadio 3 — Distress empatico quasi-egocentrico** (*dai 2-3 anni circa*)

Con la Teoria della Mente e il linguaggio, il bambino inizia a capire che l'altro ha stati interni diversi dai propri. Si muove attivamente verso l'altro — abbraccia, accarezza, condivide. Ma usa ancora ciò che *lui* ha sperimentato come consolante.

Il passaggio chiave è il **feedback correttivo**: se offro il mio orsacchiotto e l'amico continua a piangere, capisco che la soluzione efficace per me non è quella giusta per lui. Vado a prendere il *suo* orsacchiotto. Questo ciclo di tentativi, errori e correzioni porta verso un'empatia sempre più precisa.

Attenzione: l'empatia quasi-egocentrica non è "roba da bambini". Molti adulti — e operatori — cadono ancora in questo errore: offrono all'altro quello che *loro* trovano consolante, non quello di cui l'altro ha bisogno. È una delle trappole più comuni nel lavoro di cura, soprattutto con persone di culture molto diverse.

### **Stadio 4 — Empatia vera e propria** (*dai 6 anni circa*)

Con il superamento del pensiero preoperatorio (Piaget) il bambino è finalmente capace di **decentrarsi** davvero: capisce che la sua prospettiva non è l'unica, che le situazioni si vedono diversamente da posizioni diverse.

L'esperimento delle **tre montagne di Piaget** lo illustra: davanti a un plastico con tre montagne, un bambino preoperatorio descrive quello che *lui* vede, non quello che vede la bambola dall'altra parte. Dopo i 6 anni, riesce a immaginare la prospettiva dell'altro.

A questo stadio il bambino comprende anche che i propri vissuti e quelli dell'altro possono essere profondamente diversi anche in situazioni simili. La rappresentazione del vissuto altrui diventa accurata.

### **Stadio 5 — Empatia oltre la situazione** (*dall'adolescenza*)

Con il **pensiero formale** (dai 12-13 anni), l'empatia si libera dal "qui e ora". Il ragazzo sa che il suo amico con una malattia incurabile — anche se ride e scherza alla festa — porta dentro una sofferenza profonda non visibile. Riesce a empatizzare non con quello che *vede*, ma con quello che *sa* della vita dell'altro.

Tutti i tipi di empatia rimangono disponibili nell'adulto — ma non al contrario: le forme più evolute richiedono un certo sviluppo cognitivo che non si può "saltare".

---

## **La metafora della bambola: a cosa serve la nostra presenza**

Il prof usa un'immagine potente per spiegare il senso del nostro stare con l'altro. Se prendo una bambola e la lascio cadere, quello che succede dipende da tre fattori: 1.

**Il materiale di cui è fatta** — quanto è fragile o resistente 2. **L'altezza della caduta** — l'entità dell'evento 3. **Il fondo su cui cade** — marmo, legno, prato, acqua

Nel lavoro di cura, **noi possiamo modificare il fondo**. Non possiamo impedire a qualcuno di cadere dal settimo piano. Ma possiamo fare in modo che il fondo non sia di marmo freddo. La nostra presenza — anche quando non capiamo tutto, anche quando non sentiamo tutto — cambia il destino della caduta.

---

## Altri contributi rilevanti

**Janet Strayer** distingue due modalità di condivisione: - **Condivisione parallela** (meno matura): l'osservatore richiama una propria esperienza simile, con le relative emozioni. L'altro non entra davvero in gioco. - **Condivisione transitoria** (più matura): l'osservatore entra nel vissuto specifico dell'altro, capisce che le emozioni di quell'altro possono essere diverse dalle proprie.

**Doris Bischof-Köhler** aggiunge: l'empatia non si attiva solo dallo stimolo emotivo (il pianto), ma anche dalla **situazione stessa**. Posso empatizzare con qualcuno che vedo congedarsi dalla madre all'asilo anche se non piange, perché riconosco la situazione.

**Serge Tisseron (2013)** propone tre livelli di empatia, dove il più maturo è l'**empatia intersoggettiva** — che presuppone l'adozione intenzionale del punto di vista altrui e include anche l'**empatia verso sé stessi**: la capacità di essere ricettivi ai propri stati emotivi e cognitivi senza giudicarsi severamente.

---

## I sei bias dell'empatia — Dove l'empatia sbaglia

Qui arriva la parte più scomoda — e più utile. Il prof è esplicito: non è detto che più empatia significhi meglio. Esistono errori strutturali che l'empatia può far compiere. Li chiamiamo **bias empatici** (questa categorizzazione è elaborazione originale del prof, non esiste così in letteratura).

### Bias 1 — Non empatizziamo con tutti ugualmente

L'empatia si attiva di più verso chi ci somiglia, chi appartiene al nostro gruppo, chi troviamo attraente. Più l'altro è diverso da noi, meno l'empatia emotiva scatta spontaneamente. Hoffman lo chiama **bias della familiarità**: l'empatia si riduce progressivamente più l'interlocutore si discosta da noi per somiglianza, cultura, gruppo di appartenenza.

In ambito professionale questo è un rischio: il lavoratore del sociale incontra persone molto diverse da lui, e deve essere consapevole che la dimensione emotiva gli sarà meno utile — dovrà ricorrere di più alla componente cognitiva.

## **Bias 2 — "Brutti, sporchi e colpevoli" inibiscono la risposta empatica**

Se attribuiamo a qualcuno la responsabilità della propria condizione (o se lo troviamo esteticamente ripugnante), la risposta empatica si riduce. Uno studio su persone con HIV lo dimostra: verso chi aveva contratto il virus per trasfusione c'era più risonanza empatica che verso chi l'aveva contratto per scambio di siringhe. Il giudizio distorce l'empatia.

## **Bias 3 — Inganno e invidia non sono amici dell'empatia**

Verso chi ci ha ingannato o verso chi invidiamo, l'empatia emotiva si riduce. Adam Smith nel 1759 aveva già notato che l'invidia impedisce la simpatia verso chi ha successo. In ambito professionale: se un utente ci ha fregati, vigilare sulla propria risposta empatica verso di lui richiede uno sforzo consapevole.

## **Bias 4 — L'empatia non è sensibile ai numeri**

Una statistica non mobilita l'empatia. Una singola persona con nome, volto e storia, sì. Stalin lo sintetizzava cinicamente: "Una morte è una tragedia, un milione di morti è una statistica." La personalizzazione — come quella di Vanessa Trevisan che sul quotidiano ha dato un volto al padre morto di Covid — permette di empatizzare dove i numeri non ci riescono.

Il rovescio della medaglia: focalizzarsi sul singolo (effetto Sheri Summers nell'esperimento di Batson) può portare a favoritismi ingiusti a danno di altri con uguale diritto alla cura.

## **Bias 5 — L'empatia non rende necessariamente più buoni**

Gli psicopatici possono essere molto capaci di empatia **cognitiva** — sanno leggere benissimo la prospettiva e i bisogni dell'altro. La usano per manipolare. Quello che



manca loro è l'empatia **emotiva** (registro affettivo automatico). Keyzers e Gazzola (2014) li descrivono come capaci di modulare la propria empatia come la manopola del volume di una radio: alzandola per conquistare fiducia, abbassandola nel momento del danno.

## **Bias 6 — L'empatia è faticosa e dolorosa, può portare a evitare la sofferenza**

Sentire il dolore altrui fa stare male. La risposta naturale è togliere la mano dal fornello caldo. Ma nel lavoro di cura non si può sempre farlo. Hoffman parla di **sovrattivazione empatica**: quando la sofferenza empatica dell'operatore diventa intollerabile, può uscire del tutto dalla modalità empatica — distrarsi, allontanarsi, non vedere più.

Troppa empatia può anche impedire scelte educativamente necessarie (come dire di no ai figli) perché insopportabile assistere al disagio altrui.

"Troppa empatia e poca empatia creano entrambe problemi." — Boella, 2018

---

## **Empatia, simpatia e compassione: non sono la stessa cosa**

Un ultimo punto fondamentale. **Simpatia, empatia e compassione** sono spesso confuse, ma differiscono nella struttura della risposta alla sofferenza.

La **compassione** (*com-patire*, soffrire con) si caratterizza per: - Riconoscimento della sofferenza - Relazione con la persona che soffre - **Reazione proattiva**: non solo si sente la sofferenza, si è motivati a migliorare il benessere dell'altro

Singer e Klimecki (2014): la compassione è "sentire *per* l'altro" (*feeling for*), non "sentire *con* l'altro" (*feeling with*). Non implica necessariamente la condivisione del dolore, ma la motivazione a ridurlo.

---

# Concetti chiave

| Termine                                    | Significato                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einfühlung</b>                          | "Sentire dentro" — termine tedesco originario, tradotto come empatia nel 1909       |
| <b>Simulazione incarnata</b>               | Meccanismo neurologico per cui imitiamo internamente ciò che vediamo fare (Gallese) |
| <b>Neuroni specchio</b>                    | Neuroni attivi sia nell'azione propria che nell'osservazione dell'azione altrui     |
| <b>Contagio emotivo</b>                    | Forma primitiva di empatia: involontaria, automatica, senza mediazione cognitiva    |
| <b>Distress empatico globale</b>           | Prima forma di empatia (neonato): non distingue sé dall'altro                       |
| <b>Distress empatico egocentrico</b>       | Tentativi di aiuto basati su ciò che è consolante per sé                            |
| <b>Distress empatico quasi-egocentrico</b> | Empatia con feedback correttivi: inizia a capire il bisogno specifico dell'altro    |
| <b>TOM — Theory of Mind</b>                | Capacità di dedurre stati mentali, credenze ed emozioni altrui (circa 4 anni)       |
| <b>Assunzione di prospettiva</b>           | Capacità cognitiva di vedere le cose dal punto di vista dell'altro                  |
| <b>Decentramento</b>                       | Uscire dalla propria prospettiva egocentrica (Piaget, dai 6 anni)                   |
| <b>Bias empatico</b>                       | Errori sistematici che distorcono o bloccano la risposta empatica                   |
| <b>Sovrattivazione empatica</b>            | Quando la sofferenza empatica diventa intollerabile e porta all'allontanamento      |
| <b>Compassione</b>                         |                                                                                     |

| Termine                               | Significato                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Sentire per l'altro + motivazione proattiva a migliorarne il benessere |
| <b>Empatia cognitiva</b>              | Componente razionale: decodifica e assunzione di prospettiva           |
| <b>Empatia affettiva/<br/>emotiva</b> | Componente emotiva: risonanza, sentire quello che sente l'altro        |

---

## Collegamenti

- **Lezione 01 (Guarigione e cura):** il tema del "rimanere con l'altro anche quando so già come andrà a finire" torna qui — stare è già un atto empatico
- **Lezione 02 (Violenza e relazioni d'aiuto — Elisa Milani):** i manipolatori usano l'empatia cognitiva per i propri scopi; l'empatia non è sinonimo di bontà
- **Lettere consigliate:** Paul Bloom, *Contro l'empatia* (2019) — Luigina Mortari, *Avere cura* (2006)
- **Temi aperti:** differenza tra empatia cognitiva e affettiva nella psicopatia — sviluppo della compassione come alternativa più stabile all'empatia nel lavoro di cura

---

Jony, questa lezione è tosta ma ricca. Quello che hai in mano adesso non è solo teoria: è uno strumento per lavorare meglio con le persone. Continua così.